外科学 外科总论

核心精讲·其它外科总论

（性感认识：先会点再说）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、无菌术

消毒杀灭致病微生物，不杀灭芽孢

1.灭菌（杀灭芽孢）蒸、煮、泡、低温料理、烧烤、微波炉

①高压蒸汽（最常用）：适合大多数物品，有效期 2 周

②化学气体（环氧乙烷、过氧化氢低温等离子体、低温甲醛蒸汽）：不耐高温如仪器、导管、内镜（胰岛内分泌）

③煮沸持续 1 小时：耐高温如金属器械、玻璃、橡胶 玻璃本身可以碰水，也可以不碰水

④戊二醛等化学药液浸泡 10 小时：锐利器械、内镜

⑤干热/火烧：玻璃、粉剂、油剂 不耐湿

⑥电离辐射（γ 射线）

苯扎溴铵或氯己定消毒创面，不能用酒精（就你笨）这三者只能拿来消毒，不能拿来灭菌

2.手术区

①皮肤消毒范围包括切口周围 15cm，由中心向四周消毒（但感染区/肛门区由外周开始）

②无菌区域：肩部以下、ttsx 腰部以上的身前区（至腋中线）、双侧手臂、手术台面以上

③手术时若手套破损或接触到有菌地方→重新洗手+消毒+更换手套 关注手套破没破

④手术室：

铜绿假单胞菌、气性坏疽	40%甲醛+高锰酸钾熏蒸（高钾血症气绿了）
铜绿假单胞菌、乙肝、开放性结核	器械在 2000mg/L 有效氯中浸泡 1 小时+高压蒸汽灭菌（绿甘蔗真绿）

二、急性肝衰竭

①我国最主要原因：乙肝

胆红素↑（肝C性黄疸）

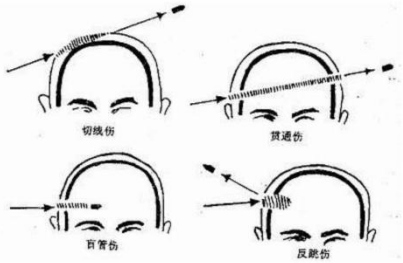
②肝性脑病（扑翼样震颤、肝臭），肝浊音界进行性缩小，凝血酶原活动度 PTA≤40%、胆酶分离 说明肝细胞坏死严重

硫醇 正儿八经缩小 转氨酶不高（肝细胞坏死）

三、创伤

1.按伤后皮肤或黏膜完整性分类：闭合伤、开放伤（贯通伤和盲管伤）

有出入口 只有入口没有出口



2.止血带 有造成肢体缺血风险

①适合加压包扎无法止血的四肢大出血

②禁用细绳、电线 接触面积小，压强大→易损坏N

③每隔 1 小时放松 1-2 分钟、使用不超过 4 小时 避免肢体缺血坏死

3.开放伤清创 骨折也是

①切除创缘皮肤 1-2mm

②伤后 6-8 小时内（头面部 血供丰富 12 小时内、头皮 24 小时内）：清创后一期缝合（头皮一天都丝滑）

③超过时间、火器伤、渗液多/污染重/感染几率大：清创后不一期缝合

子弹、炸药（伤情不易判断）

4.优先抢救危及生命的：心跳呼吸骤停、窒息、张力性气胸、休克等

围术期Ⅰ类可能污染切口：6h内伤口清创术缝合（过了6-8h细菌明显繁殖，属于污染的切口）